



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : منال على محمد موسي
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الخليفة
رقم البطاقة : 27001263200045 رقم التليفون : 01220477987
العنوان : ممممممممممممممممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 26-01-1970 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 22-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال علي محمد موسى National ID: 27001263200045	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

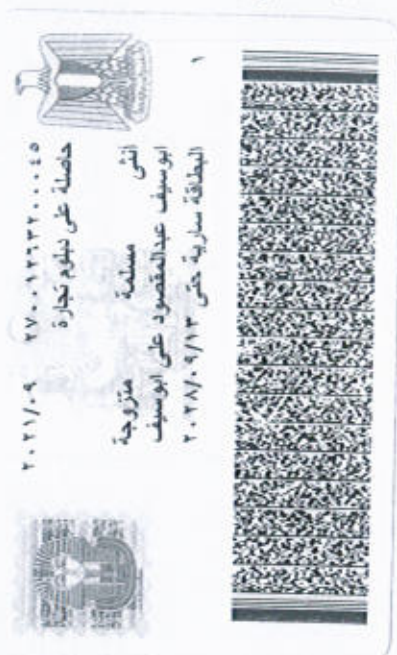
نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالثدي و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





Pathology Report

ص ٢١

Name: منال علي محمد موسى Age: years.

Clinical data: Right breast mass.

Specimen type: Right MRM post chemo therapy.

Date (Received): 14/4/2021

Date (reported): /4/2021

Lab. Number: 822/21

Hospital Number:

Gross Description:

Right MRM 24x18x3cm, covering skin 19X17cm, nipple is unremarkable, cut section revealed diffuse greyish white area, dissection of axilla revealed 16LNs, up to 2x1cm.

Microscopic Examination:

Sections examined revealed breast tissue showed fibrosis, elastosis with areas of necrosis and giant cell reaction. No remnants of tumor tissue.

Free nipple and resection margins. The examined Axillary L.Ns were free of metastatic deposits 0/16.

Diagnosis:

Right breast mass, Right MRM post chemo therapy.

No remnants of tumor tissue.

Complete pathological response (CPR).

Free Nipple.

Free Margin.

L.N .status 0/16.

Stage ypT0 ypN0.

Prof. Dr. Gamal Abd El Atty.

Dr. Enas Mohamed Ali.

PATIENT NAME: MANAL ALI MOHAMMED MOSA
GENDER: Female
AGE: 50 y

PATIENT ID #: 2020130748
ORDER #: 808664,808665
DATE OF SERVICE: 23-Sep-2020 09:49 AM

Report: - all studies

**MULTISLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN
AND PELVIS WITH TRIPHASIC LIVER STUDY REVEALED:**

- *A known case of right breast cancer.*

(I) Chest:

- Right breast UIQ irregular enhancing parenchymal mass is seen measuring 28 x 15 mm.
- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- No sizable pulmonary parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.
- Bilobar tiny thyroid nodules.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged showing homogenous low CT density . No suspicious hepatic focal lesions (geographic hyperdense non-enhancing area is seen at segment IVa at adjacent location to the portal vein, consistent with area of focal fatty sparing)
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys (apart from small bilateral simple cortical cysts) , aorta and IVC.
- Under-filled urinary bladder showing no stones.
- Slightly bulky uterus.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No CT evidence of gross suspicious lytic or sclerotic osseous lesions.

OPINION:

Known case of right breast cancer showing:

- *Right breast parenchymal mass.*
- *No evidence of distant metastatic disease in the current study.*

Reported By,

Dr. Amr Farouk ,MD
Dr. Peter Fahmy, MSc

23-Sep-2020 01:14 PM

PATIENT NAME: MANAL ALI MOHAMMED MOSA

GENDER: Female

AGE: 50 y

PATIENT ID #: 2020130748

ORDER #: 808666

DATE OF SERVICE: 23-Sep-2020 02:33 PM

Report:

99MTC-MDP BONE SCAN

Desired Information: -

skeletal survey.

Technique:

Delayed Whole body imaging in anterior and posterior projection performed 2 hours after I.V administration of 20 mCi 99m Tc-MDP in the following manner:

Report:

No hot spot that account for osseous deposits could be detected allover the surveyed skeleton.

Degenerative changes are seen over dorso-lumbar vertebrae.

Arthritic changes are seen over both knees.

Both kidneys are normally visualized.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Reported By,

Ass. Prof. Huda Fathy Elsayed

23-Sep-2020 04:45 PM